حالة كل أسبوع™ · المكافأة 3

قوالب عرض الحالة للزملاء

هياكل جاهزة لعرض حالة بشكل منظم في 60 ثانية أو 5 دقائق أو على ملصق علمي، مع قوالب بين أقواس مربعة وقائمة تحقق للسجلات.

دليل طبيب التقويم

المحتويات

قبل العرض: أربع قواعد

العرض في 60 ثانية

العرض في 5 دقائق

العرض بالملصق العلمي

طلب رأي مكتوب من زميل

قائمة تحقق السجلات: الصور، الأمثلة، الصور الشعاعية

مقارنة قبل / بعد

أخطاء العرض الشائعة

الخطوة التالية

البداية

قبل العرض: أربع قواعد

العمود الفقري نفسه أيًّا كان الشكل.

1. **حدّد سؤالًا واحدًا.** «ماذا أريد منكم في هذه الحالة؟» رأيًا أم قرارًا أم تعليمًا؟ الجملة الأولى والأخيرة من العرض ترتبطان بهذا السؤال.
2. **استخدم الترتيب نفسه.** الهوية والشكوى ← الموجودات ← قائمة المشكلات ← الخطة ← السؤال أو النتيجة.
3. **أخفِ هوية المريض.** احذف المعرّفات مثل الاسم ورقم الملف والتاريخ. وبالنسبة لصور الوجه، ارجع إلى نموذج الموافقة المعتمد في عيادتك.
4. **اجعل السجلات موحّدة.** الزاوية نفسها، الإضاءة نفسها، الترتيب نفسه. ضع العلامات في قائمة تحقق السجلات قبل العرض.

الشكل	متى	الهدف الرئيسي
60 ثانية	استشارة قصيرة داخل العيادة، حديث في الممر	أخذ رأي في قرار واحد
5 دقائق	اجتماع الحالات، مجموعة الدراسة	مناقشة الخطة أو شرح حالة منتهية
ملصق علمي	المؤتمرات والفعاليات العلمية	جعل الحالة مفهومة من نظرة واحدة

الشكل 1

العرض في 60 ثانية

أربع كتل، كل منها جملة أو جملتان.

المدة	الكتلة	المحتوى
0–10 ث	الهوية والشكوى	العمر، الجنس، حالة النمو، الشكوى بكلمات المريض نفسه.
10–30 ث	الموجودات الرئيسية	علاقة الرحى/الناب، البروز الأفقي (overjet)/التغطية العمودية (overbite)، الازدحام، قيمتان أو ثلاث قيم سيفالومترية، سابقة مهمة.
30–45 ث	المشكلة والخيارات	أهم مشكلة وخياران تفكر فيهما.
45–60 ث	السؤال	ما تريده من زميلك بالضبط.

القالب

[طفل / طفلة / رجل / امرأة] عمره **[العمر]** سنة، **[حالة النمو]**. الشكوى: «**[جملة المريض]**».

علاقة الرحى **[يمين / يسار]**، البروز الأفقي **[mm]**، التغطية العمودية **[mm]**. ازدحام **[mm]** في الأعلى و**[mm]** في الأسفل. ANB **[°]**، FMA **[°]**. سابقة مهمة: **[عادة / رضّ / الصحة العامة]**.

أرى أن المشكلة الرئيسية **[المشكلة]**. أفكر في خيارين: **[الخيار 1]** أو **[الخيار 2]**.

سؤالي لكم: **[سؤال واحد واضح]**؟

مثال معبّأ (افتراضي)

مريض ذكر عمره 13 سنة، قريب من طفرة النمو. الشكوى: «أسناني بارزة للأمام».

علاقة الرحى صنف ثانٍ وحدة كاملة في الجانبين، البروز الأفقي 8 mm، التغطية العمودية 5 mm. ازدحام 4 mm في الأعلى و3 mm في الأسفل. ANB 6°، FMA 25°. توجد سابقة كسر تاجي في الثنية العلوية قبل سنة.

أرى أن المشكلة الرئيسية صنف ثانٍ ناتج عن تراجع الفك السفلي مع بروز أفقي زائد. أفكر في خيارين: البدء بجهاز وظيفي، أو تمويه بالقلع بعد انتهاء النمو.

سؤالي لكم: هل كنتم ستبدؤون الجهاز الوظيفي الآن لدى هذا المريض الذي لديه سابقة رضّ؟

الشكل 2

العرض في 5 دقائق

10 شرائح، نحو 5 دقائق إجمالًا. فكرة واحدة في كل شريحة.

الشريحة	المدة	العنوان	المحتوى
1	30 ث	العنوان والسؤال	عنوان الحالة والسؤال الوحيد للعرض أو رسالته الرئيسية.
2	30 ث	الهوية والشكوى	العمر، حالة النمو، الشكوى، السوابق ذات الصلة.
3	40 ث	الصور خارج الفم	أمامية في الراحة، أمامية مع الابتسامة، جانبية. تعليق على الملامح بجملة واحدة.
4	40 ث	الصور داخل الفم	أمامية، يمنى، يسرى، إطباقية علوية وسفلية. موجودات العضة بالترتيب.
5	30 ث	الصور الشعاعية	موجودات الصورة البانورامية (بترتيب «الأداة 1 · قائمة التحقق الكاملة للصورة البانورامية») والصورة السيفالومترية الجانبية.
6	30 ث	الملخص السيفالومتري	ثمانية قياسات وتفسير في ثلاث جمل: سهمي، عمودي، سني.
7	30 ث	قائمة المشكلات	السهمي، العمودي، العرضي، المسافة، وشكوى المريض.
8	30 ث	الأهداف والخطة	الأهداف والخيارات والخطة المختارة مع المبرر.
9	20 ث	المسار أو النتيجة	في الحالة الجارية: المرحلة الحالية؛ في الحالة المنتهية: قبل/بعد.
10	20 ث	السؤال أو الدرس	سؤال للنقاش أو درس مستفاد من هذه الحالة.

شريحة قائمة المشكلات · القالب

السهمي: [علاقة الرحى/الناب، البروز الأفقي، المصدر الهيكلي]

العمودي: [التغطية العمودية، النمط العمودي]

العرضي: [العضة المعكوسة، الخطوط المتوسطة]

المسافة: [الازدحام/المسافات في الأعلى والأسفل، mm]

شكوى المريض: [جملة المريض]

شريحة الخطة · القالب

الأهداف: 1) [هدف] 2) [هدف] 3) [هدف]

الخيارات: أ) [خيار] · ب) [خيار]

الخطة المختارة ومبررها: [الخطة]، لأن [المبرر].

الارتكاز والتثبيت: [خطة الارتكاز] · [خطة التثبيت]

الشكل 3

العرض بالملصق العلمي

نص قليل بما يكفي ليُقرأ من مسافة متر، وتنظيم يكفي ليُفهم من نظرة واحدة.

العنوان

[عنوان يصف الحالة في جملة واحدة] · [اسم المؤسسة أو العيادة، بالصيغة التي تطلبها الفعالية]

المقدمة

[لماذا الحالة مثيرة للاهتمام، 3–2 جمل]

معلومات الحالة

[العمر، الشكوى، السوابق؛ الصور خارج الفم وداخله]

التشخيص

[جدول الملخص السيفالومتري وقائمة المشكلات]

الخطة

[الأهداف، الخيارات والخطة المختارة]

مسار العلاج

[المراحل والمدة؛ الصور المرحلية]

النتيجة

[صور قبل / بعد، مقارنة القياسات السيفالومترية النهائية]

النقاش والدروس المستفادة

[3–2 دروس من هذه الحالة؛ قصيرة وملموسة]

قائمة تحقق الملصق

- [ ] قرأت قواعد الحجم والشكل الخاصة بالفعالية.
- [ ] كل قسم لا يتجاوز بضع جمل قصيرة.
- [ ] الصور بالزاوية والإضاءة نفسيهما، وقبل/بعد متجاورتان.
- [ ] القيم السيفالومترية في جدول ولا تتكرر في النص.
- [ ] حُذفت معرّفات المريض؛ وأُخذت الموافقة عبر نموذج الموافقة المعتمد في عيادتك.
- [ ] العنوان يُقرأ من بعيد.

قالب

طلب رأي مكتوب من زميل

الرسالة القصيرة المنظمة المركّزة على سؤال واحد تحصل على رد أسرع وأوضح.

إلى زميل أخصائي تقويم

الزميل العزيز د. **[اسم الزميل]**، تحية طيبة،

أرجو التكرم بإبداء رأيك باختصار في حالة. المريض عمره **[العمر]** سنة، **[حالة النمو]**. الموجودات الرئيسية: **[علاقة الرحى، البروز الأفقي، التغطية العمودية، الازدحام]**؛ **[°]** ANB، **[°]** FMA.

أنا متردد بين خيارين: **[الخيار 1]** و**[الخيار 2]**. أميل إلى **[الخيار]**، لأن **[المبرر]**.

سؤالي: **[سؤال واحد]**؟ السجلات مرفقة بعد إخفاء هوية المريض.

مع الشكر، **[اسم الطبيب]** · **[اسم العيادة]**

ملاحظة استشارة إلى الجرّاح أو أخصائي اللثة أو أخصائي التعويضات

المريض: **[رمز الملف]**، **[العمر]** · **سبب الاستشارة:** **[مثلًا: تقييم الخيار الجراحي / تأكيد الثبات اللثوي / تخطيط موضع الزرعة]**

الموجودات التقويمية: **[ملخص قصير]**

الخطة التقويمية: **[حركات الأسنان المخطط لها والمراحل التقديرية]**

المطلوب منكم: **[سؤال واضح أو موافقة]**

المرفقات: **[الصور، الصور الشعاعية، الملخص السيفالومتري]**

قائمة تحقق

قائمة تحقق السجلات

القائمة نفسها في كل سجل أولي ومرحلي ونهائي. أكمل النواقص قبل العرض.

الصور خارج الفم

- [ ] أمامية، في الراحة
- [ ] أمامية، مع الابتسامة
- [ ] جانبية، في الراحة
- [ ] ابتسامة بزاوية ثلاثة أرباع
- [ ] من الأسفل عند الحاجة (لعدم التناظر)

الصور داخل الفم

- [ ] أمامية، في وضع الإطباق
- [ ] دهليزية يمنى
- [ ] دهليزية يسرى
- [ ] إطباقية علوية
- [ ] إطباقية سفلية
- [ ] منظر البروز الأفقي (من الجانب)

الأمثلة

- [ ] سجل كامل للقوس العلوي والسفلي (رقمي أو جبسي)
- [ ] تسجيل العضة
- [ ] تسجيل العلاقة المركزية عند الحاجة
- [ ] نتائج تحليل المسافة وBolton

الصور الشعاعية

- [ ] الصورة البانورامية (مقروءة بترتيب الأداة 1)
- [ ] الصورة السيفالومترية الجانبية والتتبع
- [ ] تصوير إضافي حسب الاستطباب
- [ ] الصور الشعاعية المرحلية والنهائية

معيار التصوير

- [ ] الخلفية والإضاءة نفسهما؛ دون انعكاسات.
- [ ] الرأس في الوضع الطبيعي، ومستوى فرانكفورت موازٍ للأرض تقريبًا في الصورة الجانبية.
- [ ] استخدام مبعدات الشفاه والمرايا في الصور داخل الفم نفسه في كل سجل.
- [ ] لا يوجد اسم المريض في أسماء الملفات؛ بل رمز الملف في عيادتك ومرحلة السجل (أولي / مرحلي / نهائي).

عرض النتيجة

مقارنة قبل / بعد

الظروف نفسها لإظهار التغيّر بصدق.

القاعدة	السبب
الزاوية نفسها والتكبير نفسه	الزاوية المختلفة قد تبالغ في التغيّر أو تخفيه.
الإضاءة والخلفية نفسهما	اختلاف اللون والتباين يُفهم وكأنه تغيّر.
متجاورتان أو متراكبتان	يجب أن يتمكن المشاهد من إجراء المقارنة بنفسه.
قدّم القيم السيفالومترية في جدول	البداية والنهاية والفرق في ثلاثة أعمدة.
اذكر حدود النتيجة	كتابة الأهداف التي لم تتحقق أيضًا تجعل العرض موثوقًا.

جدول المقارنة السيفالومترية · القالب

القياس	البداية	النهاية	الفرق
SNA			
SNB			
ANB			
Wits			
FMA			
SN-GoMe			
IMPA			
U1-SN			

تجنّبها

أخطاء العرض الشائعة

تصحيح من جملة واحدة لكل منها.

الخطأ	التصحيح
إخفاء السؤال حتى النهاية	اطرح السؤال في الجملة الأولى، وكرره في الجملة الأخيرة.
قراءة كل القيم السيفالومترية	ثمانية قياسات في جدول، وشفهيًا تفسير من ثلاث جمل فقط.
تخطي قائمة المشكلات والبدء بالجهاز	أولًا قائمة المشكلات والأهداف، ثم الميكانيكا.
صور قبل/بعد بزوايا وإضاءة مختلفة	طبّق قائمة تحقق السجلات من البداية.
ترك معرّفات المريض على الشريحة	راجع كل شيء قبل العرض، بما في ذلك أسماء الملفات.
عرض الحالات الناجحة فقط	عرض حالة متعثرة يكون في الغالب أكثر فائدة تعليمية.
تجاوز الوقت المحدد	تدرّب مرة واحدة بصوت مرتفع مع ساعة توقيت.

مادة تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري ولا عن قرار الطبيب ولا عن رأي الأخصائي.

الخطوة التالية

اختر حالة هذا الأسبوع واملأ قالب الستين ثانية. حالات **الأسابيع 52–49** في «برنامج التدريب على الحالات لمدة 52 أسبوعًا» مثالية للتدرّب على العرض.

لشريحة الملخص السيفالومتري استخدم طريقة الجمل الثلاث في **«دفتر تمارين القياسات السيفالومترية»**. ولقائمة المشكلات والخطة افتح **«الأداة 4 · المخطِّط السريري ذو المراحل الأربع»** في دليل طبيب التقويم.